Azienda Ospedaliera Santa Maria della Rupe
Dipartimento di Emergenza-Urgenza e Area Critica
S.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
Terapia Intensiva Generale - 8 posti letto
Direttore: Prof.ssa Ludovica Ferraris-Bellini

Via Vittorio Veneto 197
19124 La Spezia
Medici TI 0187 533912
Fax 0187 533950
ti.generale@aosmr.example.it

Ai Colleghi della S.C. Pneumologia - sede
e p.c. al Dott. Ettore Lagomarsino
Medico di Medicina Generale, Sarzana

LETTERA DI DIMISSIONE DALLA TERAPIA INTENSIVA

Relazione clinica di trasferimento interno

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**Dell'Orto**	Nome:	**Rosa**
Nata il:	**08/02/1963 a Genova**	Sesso:	**F**
Residenza:	**Via Variante Aurelia 54, 19038 Sarzana**	Tessera sanitaria:	**80380120675843336143**
Nosologico:	**2025-TI-000377**	Cartella clinica:	**TI/25/0042**
Gruppo sanguigno:	**A Rh negativo**	Età:	**61 anni**

Codice fiscale D L L R S O 6 3 B 4 8 D 9 6 9 B

Ingresso in TI:	14/01/2025 ore 03:20	Provenienza:	Pronto Soccorso / Shock Room	Dimissione da TI:	29/01/2025 ore 11:00
Destinazione:	S.C. Pneumologia, letto 14	Degenza in TI:	15 giorni	Medico referente:	Dott.ssa Bianca Gualtieri

CONTATTI E VOLONTÀ ESPRESSE DALLA PAZIENTE

Familiari di riferimento

Marito e contatto di emergenza: sig. Walter Bianco, tel. +39 335 610 2284.
Figlia: sig.ra Sole Bianco, tel. +39 347 902 1175.
La paziente autorizza la comunicazione di informazioni cliniche telefoniche solo al marito.

Disposizioni anticipate di trattamento

La sig.ra Dell'Orto, Testimone di Geova, ha depositato DAT in data 12/09/2019 con **rifiuto di emotrasfusioni** ed emocomponenti (emazie, plasma, piastrine). Accetta albumina, eritropoietina e frazioni minori. Volontà riconfermata dalla paziente, lucida, il 24/01/2025 (1).

MOTIVO DEL RICOVERO

La sig.ra Rosa Dell'Orto giunge in PS la notte del 14 gennaio 2025, accompagnata dal marito, per febbre elevata, dispnea ingravescente e stato confusionale insorti da 48 ore. All'arrivo PA 78/42 mmHg, FC 128 bpm, FR 34 atti/min, SpO2 82% in maschera Venturi, Glasgow Coma Scale GCS 13, lattati 6,4 mmol/L. Rx torace: addensamenti parenchimali bilaterali. Dopo riempimento volemico con cristalloidi (30 mL/kg) persistenza di ipotensione: avviata noradrenalina e richiesta consulenza rianimatoria (Dott. Samuel Owusu), con trasferimento in TI.

ANAMNESI

Asma bronchiale lieve intermittente. Ipotiroidismo dopo tiroidectomia totale (2011) per gozzo multinodulare. Disturbo ansioso-depressivo in terapia con sertralina 50 mg, seguita dal CSM. Allergia al mezzo di contrasto iodato (orticaria generalizzata nel 2017). Ex fumatrice (15 pack-years). Lavora come insegnante di scuola primaria. Vive con il marito; autonoma nelle ADL.

PUNTEGGI DI GRAVITÀ

Score	Ingresso	72 ore	Dimissione da TI	Note
SOFA	11 punti	8 punti	2 punti	cardiovascolare, respiratorio, renale, coagulazione
APACHE II	24 punti	-	-	mortalità attesa circa 40%
SAPS II	52 punti	-	-	
RASS (Richmond)	-	RASS -4	RASS 0	sedazione profonda nelle prime 72 ore
CAM-ICU	-	non valutabile	assenza di delirium	delirium ipoattivo dopo l'estubazione

DECORSO CLINICO PER PROBLEMI

1. Respiratorio

ARDS moderata (P/F 118 all'ingresso). Intubazione orotracheale il 14/01/2025 e ventilazione meccanica protettiva (Vt 6 mL/kg di peso ideale, PEEP 12 cmH2O, pressione di plateau < 28 cmH2O). Eseguiti due cicli di pronazione di 16 ore il 15/01/2025 e il 16/01/2025 con miglioramento dell'ossigenazione. Svezzamento in pressione di supporto dal 20/01/2025; estubazione il 22/01/2025 e successiva ventilazione non invasiva intermittente per 36 ore. Attualmente in ossigenoterapia con occhialini nasali a 2 L/min, SpO2 95%. Non posizionato catetere di Swan-Ganz.

2. Emodinamico

Shock settico trattato con noradrenalina fino a 0,35 µg/kg/min e idrocortisone 200 mg/die dal 14/01/2025; amine sospese il 19/01/2025. Ecocardiogramma (Dott.ssa Bianca Gualtieri): FE 50%, VCI collassabile, assenza di versamento pericardico. Steroide in scalo, sospeso il 25 gennaio.

3. Infettivologico

Polmonite pneumococcica bilaterale con batteriemia: emocolture e BAL positivi per Streptococcus pneumoniae penicillino-sensibile; colorazione di Gram del BAL con diplococchi Gram positivi. Terapia iniziale con ceftriaxone 2 g + azitromicina 500 mg, poi de-escalation a amoxicillina su indicazione dell'infettivologo Dott. Pietro Canepa. PCT in netta riduzione. Tampone nasofaringeo per virus respiratori negativo.

4. Renale

Danno renale acuto KDIGO 2 su base settica (creatinina massima 3,12 mg/dL), gestito senza terapia sostitutiva renale. Diuresi valida dalla quinta giornata, funzione renale in miglioramento.

5. Ematologico e gestione senza emotrasfusioni

Anemia con Hb minima 6,8 g/dL il 20 gennaio. Nel rispetto delle volontà espresse non sono state eseguite emotrasfusioni; strategia di patient blood management concordata con il marito, sig. Bianco, e con la Direzione Sanitaria: epoetina alfa 40.000 UI sottocute settimanale, ferro carbossimaltosio 1000 mg e.v., acido folico, riduzione dei prelievi con provette pediatriche. Test di Coombs diretto negativo. Hb alla dimissione 8,9 g/dL in risalita.

6. Neurologico e psicologico

Sedazione con propofol e fentanil, poi dexmedetomidina. Dopo l'estubazione delirium ipoattivo, risolto con misure non farmacologiche e presenza dei familiari in reparto aperto. Debolezza acquisita in terapia intensiva (MRC sum score MRC 42/60). Colloqui di supporto con la psicologa dott.ssa Giovanna Ottonello; ripresa la sertralina dal 26 gennaio. Diario di TI consegnato alla paziente.

DISPOSITIVI E ACCESSI VASCOLARI

Dispositivo	Sede	Posizionato	Rimosso	Operatore
CVC 3 lumi (eco-guidato)	vena giugulare interna destra	14/01/2025	28/01/2025	Dott. Samuel Owusu
Catetere arterioso	arteria radiale sinistra	14/01/2025	27/01/2025	dott. Tommaso Ricci (medico in formazione)
Tubo orotracheale n. 7,5	-	14/01/2025	22/01/2025	Dott. Samuel Owusu
Sondino naso-gastrico	narice destra	15/01/2025	24/01/2025	inf. Marco Ghiglione
Catetere vescicale 14 Ch	-	14/01/2025	in sede	inf. Debora Lanteri (rimuovere entro 48 ore)
Agocannula 20 G	avambraccio destro	27/01/2025	in sede	inf. Marco Ghiglione

ESAMI DI LABORATORIO E MICROBIOLOGIA

Esame	Ingresso	72 ore	Dimissione	U.M.
Lattati	6,4 mmol/L	2,1	0,9	mmol/L
PCR	31,7	18,2	3,4	mg/dL
Procalcitonina	46,3	12,8	0,41	ng/mL
Creatinina	2,67	3,12 mg/dL	1,18	mg/dL
Piastrine	96.000	71.000	214.000	/µL
P/F ratio	118	196	310	mmHg

Campione	Prelievo	Codice	Esito
Emocoltura (2 set)	14/01/2025	EC25-011482	Streptococcus pneumoniae, sensibile a penicillina
BAL	15/01/2025	BL25-000318	S. pneumoniae 10^5 UFC/mL
Antigene urinario	14/01/2025	UR25-011497	pneumococco positivo; Legionella negativo
Emocoltura di controllo	21/01/2025	EC25-012906	negativa a 5 giorni

DIAGNOSI ALLA DIMISSIONE DALLA TI

1. **Shock settico da polmonite pneumococcica bilaterale con batteriemia**, risolto.
2. ARDS moderata trattata con ventilazione meccanica invasiva (8 giorni) e pronazione.
3. Danno renale acuto KDIGO 2 in risoluzione.
4. Anemia severa gestita senza emotrasfusioni per volontà della paziente.
5. Delirium ipoattivo, risolto; debolezza acquisita in terapia intensiva.
6. Ipotiroidismo post-chirurgico; disturbo ansioso-depressivo.

TERAPIA IN ATTO AL TRASFERIMENTO

Farmaco	Dose	Orari	Note
Amoxicillina 1 g	1 g e.v.	ore 6-14-22	fino al 31/01/2025 (14 giorni totali)
Enoxaparina 4000 UI	1 fl s.c.	ore 20	profilassi; controllo piastrine
Levotiroxina 100 µg	1 cpr	ore 6	a digiuno
Sertralina 50 mg	1 cpr	ore 8	terapia abituale
Epoetina alfa 40.000 UI	1 fl s.c.	settimanale	prossima somministrazione il 02/02/2025
Pantoprazolo 40 mg	1 cpr	ore 7	sospendere alla ripresa completa dell'alimentazione
Salbutamolo spray	2 puff	al bisogno	con distanziatore

PROBLEMI APERTI E INDICAZIONI

- Proseguire riabilitazione motoria e respiratoria (fisioterapista di riferimento: Andrea Bozzo).
- Monitoraggio di emocromo, ferritina e reticolociti due volte a settimana; ogni decisione su emocomponenti deve rispettare le DAT della paziente. In caso di emergenza emorragica contattare il Comitato di Assistenza Sanitaria indicato dal marito.
- Rx torace di controllo a 4-6 settimane; visita di follow-up presso l'Ambulatorio post-Terapia Intensiva il 05/03/2025 (prenotazione PTI-25-00071).
- Rimozione del catetere vescicale entro 48 ore e controllo della ripresa della minzione spontanea.

Colloqui con i familiari: il marito, sig. W. Bianco, e la figlia Sole sono stati informati quotidianamente dell'evoluzione clinica. Le ultime informazioni sono state fornite il 28/01/2025 dalla Dott.ssa B. Gualtieri alla presenza della coordinatrice infermieristica Debora Lanteri. Le secrezioni bronchiali sono attualmente scarse, di colore bianco.

Il Medico Referente di Terapia Intensiva

Dott.ssa Bianca Gualtieri
Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione

A.O. SANTA MARIA DELLA RUPE
TERAPIA INTENSIVA GENERALE
Dott.ssa Bianca Gualtieri
Ord. Medici SP n. 2871

La Spezia, 29.01.25

IL DIRETTORE S.C.
Prof.ssa L. Ferraris-Bellini
Ord. Medici SP n. 1654

(1) Le DAT sono registrate con prot. n. DAT/2019/004417 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sarzana; il modulo di rifiuto informato è allegato alla cartella TI/25/0042.
(2) Copia della presente lettera è stata consegnata, su richiesta della paziente, al marito sig. Walter Bianco e inviata al MMG Dott. E. Lagomarsino tramite Fascicolo Sanitario Elettronico.
(3) SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; RASS: Richmond Agitation-Sedation Scale; MRC: Medical Research Council.